

EXAME CLÍNICO PSICOLÓGICO (Anamnese)

**Hipólito Carretoni Filho
Helena Bazanelli Prebianchi**

**2ª Edição
Revista e Ampliada**

159.993
C315e
2.ed.

N.Cham. 159.993 C315e 2.ed.
Autor: Carretoni Filho, Hipólito
Título: Exame clínico psicológico : (ana



2145534

Ac. 193271

Nº Pat.:2003

PUC Minas SG CE

Casa do Psicólogo®

HIPÓLITO CARRETONI FILHO é psicólogo, mestre em psicologia clínica com vários cursos de especialização, dentre eles em psiconeurolingüística e psicoterapia ericksoniana.

É professor-supervisor na Pontifícia Universidade Católica de Campinas em psicologia clínica, no curso de graduação, há mais de duas décadas e desenvolve programas de atendimento, tipo *institucional*, no âmbito do projeto SUS/PUCCAMP. Ministrou vários cursos de especialização em outras universidades e instituições. Tem publicado artigos em revistas especializadas e jornais.

O seu trabalho como autônomo está concentrado na área de psicoterapia clínica com adolescentes e adultos, individual e familiar.

Trabalhou vários anos em hospital psiquiátrico.

Foi presidente da *Sociedade de Psicologia de Campinas* e delegado do CRP/06 para Campinas e região.

HELENA BAZANELLI PREBIANCHI é psicóloga especialista em psicologia comportamental de adultos, adolescentes, crianças e psicoterapia ericksoniana e mestranda em Psicologia Clínica na PUCCAMP.

É professora-supervisora na Pontifícia Universidade Católica de Campinas das disciplinas de Estágio Supervisionado em Psicologia Clínica, Terapia Comportamental Infantil, Terapia Psicomotora e Psicodiagnóstico no curso de graduação. Tem ministrado cursos e proferido palestras em outras instituições e universidades.

Trabalhou vários anos em hospital psiquiátrico e na reabilitação de crianças excepcionais, desenvolvendo programas de estimulação essencial, orientação de famílias e treinamento de professores em instituições filantrópicas e privadas.

Sua prática clínica particular concentra-se no trabalho psicoterápico com adolescentes, adultos (individual e de casal) e crianças (inclusive terapia psicomotora).

Hipólito Carretoni Filho
e
Helena Bazanelli Prebianchi

EXAME
CLÍNICO PSICOLÓGICO
[Anamnese]

2ª Edição
Revista e Ampliada

Casa do Psicólogo®

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Carretoni F., H., e Prebianchi B., H.

Exame Clínico Psicológico (Anamnese). Hipólito
Carretoni Filho e Helena B. Prebianchi. -- São Paulo :
Casa do Psicólogo, 1999.

Bibliografia.
ISBN 85-7396-050-7

Índices para catálogo sistemático:

1. Anamnese Psicológica.
2. Exame Clínico Psicológico.
3. Exploração de Atitudes Sociais.
4. História Psicológica do Sujeito.
5. Roteiro de Atitudes Psicológicas

Título original:

Exame Clínico Psicológico, (Anamnese)

Autores:

Hipólito Carretoni Filho e Helena B. Prebianchi

© 1999 Casa do Psicólogo® Livraria e Editora Ltda.

Reservados os direitos de publicação em língua portuguesa à Casa do Psicólogo Livraria e Editora Ltda.
Rua Alves Guimarães, 436 – CEP 05410-000 – São Paulo – SP. Fone: (011) 852-4633 Fax: (011) 3064-5392
E-mail: casapsi@uol.com.br <http://www.casapsicologo.com.br>

É proibida a reprodução total ou parcial desta publicação, para qualquer finalidade, sem autorização por escrito dos editores.

Impresso no Brasil/*Printed in Brazil*

Preparação de originais: Mara Silvia Bolonhezi Bittencourt

Revisão: João Vaz

Composição Gráfica: Jesilene Fátima Godoy

Miséria, fome e doença
podem flagelar uma população.
A tragédia maior do ser humano
é o que morre dentro d'ele
enquanto vivo.

H.B.P

H.C.F

ÍNDICE

APRESENTAÇÃO	9
INTRODUÇÃO	10
I – ANAMNESE	10
A – Dados gerais	
<i>Filiação, habitat, motivos da consulta, referente, datas do estudo</i>	10-11
B – Enfermidade atual	
<i>Tempo da enfermidade, forma de início, sintomas principais, relato, antecedentes clínicos, recursos utilizados anteriormente</i>	11-12
C – História pessoal	
<i>Gestação, infância, escolaridade, adolescência e juventude, vida sexual, hábitos e interesses, atitudes</i>	12-15
D – História familiar	15
E – História socioeconômica e ocupacional	15
II – EXAME CLÍNICO PSICOLÓGICO	15
A – Observação das características gerais do comportamento	
<i>Descrição física, consciência de níveis e alerta, estados emocionais, motricidade, condutas sociais</i>	16
B – Exploração dos processos cognitivos	
<i>Atenção e concentração, processos perceptuais, orientação espacial e temporal, memória, pensamento e linguagem, inteligência</i>	16-18
C – Exploração dos estados emocionais	19
D – Exploração das atitudes sociais	19
III – EXAMES COMPLEMENTARES E AUXILIARES	20
IV – PLANO DE TRATAMENTO	21
V – EVOLUÇÃO	22
VI – IMPORTÂNCIA DAS HABILIDADES EMPÁTICAS	22
VII – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	23
VIII – ANEXOS:	
Roteiro (1)	
Roteiro (2)	

APRESENTAÇÃO

Como qualquer ciência, a psicologia reflete em seu paradigma os valores do seu tempo. Assim, as alterações socioeconômicas e geopolíticas mundiais deste final de século têm implicado uma ênfase sobre a pesquisa de resultados psicoterápicos, a qual, por sua vez, tem alimentado os desenvolvimentos teóricos e a prática aplicada das intervenções breves.

A fim de implementar esse tipo de intervenção, o psicólogo deve estar preparado para realizar diagnósticos precisos, num curto espaço de tempo.

As mudanças na estrutura social têm também, nos últimos anos, condicionado o deslocamento da práxis clínica do ambiente restrito dos consultórios particulares para centros e instituições de saúde e trabalhos de campo, obrigando o psicólogo clínico, cada vez mais, a trabalhar e comunicar-se com outros profissionais – e, portanto, ser capaz de transmitir seus resultados, numa linguagem comum, interdisciplinar.

Foram essas constatações que nos orientaram na elaboração deste trabalho. Esperamos que o presente roteiro possa constituir-se em uma ferramenta a mais para aqueles que se iniciam na prática clínica, auxiliando-os na implementação e agilização de suas tarefas.

Nesta segunda edição, revista e ampliada, optamos por incluir um tópico sobre a relação com o paciente, uma vez que ela determina, em grande parte, o sucesso de qualquer entrevista.

Em nenhum momento pretendemos oferecer um modelo definitivo, mas tão-somente fornecer uma sugestão que, temos certeza, caberá ao usuário aperfeiçoar e adaptar de forma a atender às características e necessidades do seu trabalho.

Esquema para Elaboração de uma História Clínica Psicológica (Anamnese)

INTRODUÇÃO

O presente modelo de história clínica tem por objetivo a exploração, a identificação e o planejamento de estratégias terapêuticas relacionadas aos distúrbios psíquicos. Nosso esquema é produto de um trabalho integrativo dos diversos enfoques metodológicos que existem em nosso meio e com ele desejamos resgatar os aspectos valiosos de cada um deles e enriquecê-los com nossas experiências. Não procuramos conciliar posições, senão as efetuadas através dos modelos de histórias clínicas, estudos objetivos, didáticos e enquadrados nos princípios da metodologia científica.

No ensinamento das estratégias de manejo de um caso clínico, usualmente se dá ênfase ao aspecto semiológico, sem barreiras; devem-se mostrar, também, de forma panorâmica, os procedimentos terapêuticos a serem adotados logo que o caso seja diagnosticado. Desse modo, o futuro profissional, ao assimilar didaticamente a complementação de ambos, será mais competente em seu desempenho.

Para reconhecimento e manejo das manifestações clínicas dos pacientes, recomendamos o emprego do seguinte esquema:

- I – Anamnese
- II – Exame psicológico
- III – Exames complementares e auxiliares
- IV – Plano de tratamento
- V – Evolução

I – ANAMNESE

A anamnese está orientada para a obtenção dos dados históricos dos pacientes, assim como para a sistematização dos problemas que são motivo(s) da consulta. De modo geral, este estudo compreende:

- A – Dados gerais
- B – Enfermidade atual
- C – História pessoal
- D – História familiar
- E – História socioeconômica e ocupacional

A – DADOS GERAIS

Os dados gerais poderão ser agrupados em:

- a. Filiação
- b. Habitat
- c. Motivo(s) da consulta
- d. Referente (se houver)
- e. Datas do estudo

a. Filiação

Devem-se registrar os dados pessoais do paciente. Os principais são: nome, idade, sexo, ocupação, grau de instrução, procedência, lugar e data de nascimento, estado civil etc. Os dados da filiação, além de identificar o paciente, permitem orientar a exploração clínica, relacionando determinados problemas psicológicos que, por sua incidência segundo sexo, ocupação, idade etc; são significativamente mais freqüentes. Certas perturbações têm maior incidência em determinadas etapas da vida; problemas de conduta são encontrados mais freqüentemente nas crianças; deterioramento intelectual, nos idosos. Alguns transtornos são mais freqüentes em homens e outros em mulheres. Não se deve descuidar da procedência do paciente, uma vez que o meio social ou lugar determina padrões de comportamento que podem ser responsáveis (condicionantes) para a emergência de certas sintomatologias, assim como podem repercutir favorável ou desfavoravelmente para a evolução do quadro.

Importantes, também, são os dados relativos à constelação familiar. Nesse sentido, vale a pena conhecer a idade e a profissão dos pais, o número de irmãos, suas respectivas idades e níveis de escolaridade. Esses dados geralmente nos fornecem elementos para possíveis especulações sobre

prováveis dificuldades no relacionamento familiar, em virtude da discrepância de idades, *background* etc. (tais especulações serão efetivadas ao elaborarmos a história pessoal do paciente, como veremos adiante).

b. Habitat

Neste item, incluem-se as descrições das características físicas da moradia do paciente (material de que é construída, número de cômodos, condições de higiene e saneamento) e o número de pessoas que ali residem.

c. Motivo(s) da consulta

Investiga-se, aqui, o que motivou o paciente a buscar o serviço e é a razão do estudo clínico. Uma vez que os problemas vistos pelo profissional são múltiplos, torna-se necessário delimitar as áreas do referido estudo, para maior controle de dados.

Deve-se ficar atento quanto à necessidade de identificar as queixas principal e secundárias; a perda de um ente querido – e a depressão conseqüente – poderá vir a ser o motivo (queixa) principal, enquanto insônia, perda de apetite e cefaléias, por exemplo, poderão ser classificadas como queixas secundárias.

Apesar de sua aparente simplicidade, a exploração desses aspectos deve ser procedida com rigor, porque nem sempre a queixa principal corresponde àquilo que o paciente verbaliza como motivo da busca por auxílio.

d. Referente

Devem-se anotar aqui outros dados eventuais relacionados à identificação do tipo de cliente e/ou lugar (procedência); e o tipo de encaminhamento (espontâneo ou por indicação).

e. Datas do estudo

É necessário anotar as datas em que se realizam as avaliações, posto que o curso do quadro é variável. Essa medida, além do mais, nos permitirá maior controle administrativo do documento clínico.

B – ENFERMIDADE ATUAL

Visando a uma operacionalização mais adequada, subdividimos em:

- a. Tempo da enfermidade
- b. Forma de início
- c. Sintomas principais
- d. Relato
- e. Antecedentes clínicos
- f. Recursos utilizados anteriormente

a. Tempo da enfermidade

Deve-se anotar o tempo de existência da enfermidade, de modo que o examinador tenha uma idéia da emergência do caso e do grau de desconforto manifestado pelo paciente. Se um paciente apresenta o problema há um ou dois dias, seguramente seu caso requer assistência imediata, diferentemente de quando o apresenta há seis meses ou há mais de um ano.

b. Forma de início

Existe uma relação entre o tempo da enfermidade e a forma de início; o início do problema clínico pode ser brusco ou insidioso. A enfermidade que corresponde a um início brusco geralmente é aguda e provavelmente requer assistência urgente.

A presença de sintomas como cefaléia, insônia e mal-humor que o paciente experimenta pela primeira vez de forma súbita, descartadas etiologias orgânicas, pode indicar a existência de um quadro agudo (depressão, surto psicótico etc.) que, como tal, requer atenção imediata; ao passo que a mesma sintomatologia que aparece esporadicamente desde há cinco anos poderá deixar de ser uma emergência e servir de indicador para tipificar alguns traços de personalidade (ansiosa etc.).

c. Sintomas principais

Didática e metodologicamente, é conveniente anotar os sintomas principais, o que nos dará idéia

da amplitude do problema, sua origem, assim como nos mostrará panoramicamente o caso. Desse modo, estaremos em condições de fazer uma análise minuciosa do início, da evolução e das manifestações atuais de cada um dos sintomas.

d. Relato

O relato da enfermidade corresponde à descrição minuciosa de cada um dos sintomas, tomando-se em consideração desde a forma de início, quer dizer, a evolução natural de cada um deles, destacando-se a frequência e a intensidade. Deve-se descrever o estado atual de cada sintoma, posto que alguns deles podem persistir e outros desaparecer. Devem-se diferenciar os sintomas principais dos secundários, pois muitos destes últimos são conseqüências dos primeiros, e a sua tipificação será útil para melhor manejo do caso, dado que, ao solucionar-se o sintoma desencadeante, poderão desaparecer os conseqüentes. Devem-se buscar as outras contingências da relação existente entre cada um dos sintomas; não é pelo fato de se tratar de uma história psicológica que se vai descuidar do somático, posto que existem numerosas manifestações físicas (cefaléias, retesamento dos músculos, parestesias etc.) que correspondem a problemas psicológicos primários. Do mesmo modo, é recomendável obter-se do paciente a valoração subjetiva de suas respectivas moléstias, pois não há sintomas que não se relacionem com a idiosincrasia e a personalidade de cada indivíduo.

Um relato da enfermidade que não informe o grau de comprometimento nos diversos aspectos da vida do paciente, em função de cada um dos sintomas, trará, no mínimo, um diagnóstico superficial, uma vez que, aliada à experiência subjetiva do paciente, é essa medida dos vários níveis de eficácia que determinará os objetivos terapêuticos.

e. Antecedentes clínicos

Sugerimos que na continuação se faça referência às enfermidades ou circunstâncias clínicas mais importantes que o paciente apresentou

anteriormente, sejam elas similares à atual, sejam de outra natureza, de modo que esses fatos permitam ao clínico a estruturação dos dados necessários para o esclarecimento do problema. Se no passado aconteceram problemas similares ao atual, este poderá ser diferente se apresentado pela primeira vez; os freqüentes estados depressivos podem sugerir algum problema de personalidade, ao passo que se a depressão for esporádica, poderá corresponder a uma depressão do tipo situacional.

f. Recursos utilizados anteriormente

Saber se o paciente anteriormente buscou recursos para lidar com seu problema – bem como conhecer a natureza desses recursos – auxilia-nos a ter uma idéia sobre suas concepções acerca do quadro, suas expectativas em relação ao tratamento e suas motivações.

C – HISTÓRIA PESSOAL

- a. Gestação
- b. Infância
- c. Escolaridade
- d. Adolescência e juventude
- e. Vida sexual
- f. Hábitos e interesses
- g. Atitudes

a. Gestação

Interessa-nos analisar as condições de gestação e do parto. As referências acerca da gestação são importantes (dado que é uma etapa de diferenciação biológica e aquisição das primeiras condutas reflexas pelo novo ser, cujos efeitos são de singular importância), bem como os condicionantes do meio.

Deve-se ter conhecimento da idade dos pais, do número de gestações e se houve aborto; isso é muito importante, uma vez que gestantes maiores de 35 anos têm maior probabilidade de ter filhos com comprometimentos. Deve-se registrar a natureza dos comportamentos emocionais da mãe durante a gestação. As enfermidades da mãe, as

deficiências nutritivas, assim como os problemas emocionais e as atitudes desfavoráveis (do meio ou pessoal) podem incidir significativamente no feto ou no desenvolvimento fetal.

Os conflitos emocionais agudos e duradouros da gestante podem alterar o metabolismo materno, com repercussões diretas sobre a fisiologia fetal.

Além do mais, quando obtemos informação sobre ocorrência de atitudes e/ou sentimentos desfavoráveis em relação à gravidez, devemos estar atentos para prováveis sentimentos de culpa da mãe (durante e posteriormente à gestação) que possam ser a base para atitudes inadequadas em relação ao filho. Nesse sentido, ainda, é útil lembrar que transtornos clínicos duradouros durante a gestação (principalmente aqueles que se constituíam em ameaça à integridade do feto e/ou ao bom termo da gravidez) podem acarretar, posteriormente, atitude superprotetora da mãe — não devem ser, portanto, negligenciados os aspectos psicológicos, ao investigá-los.

Devem-se obter dados sobre as condições do nascimento, uma vez que no trabalho de parto pode ter havido uma série de dificuldades decorrentes dos problemas materno-fetais e/ou pela carência de atenção médico-obstetra, gerando sofrimento fetal que, por sua vez, pode ocasionar danos neurológicos.

b. Infância

O estudo dessa área deve começar desde o nascimento, com a descrição das características do novo ser, e continuar com o desenvolvimento das diversas funções em relação aos condicionamentos (estimulação) ambientais e sociais.

O recém-nascido mostra uma série de dados úteis a observar: tamanho, peso, coloração da pele, reações reflexas, choro etc. A coloração escura da pele no recém-nascido e o atraso do choro podem corresponder a um estado anóxico e, portanto, serem indicadores de um provável comprometimento neurológico.

Depois do nascimento, a criança é exposta a uma série de traumatismos do nosso meio, como

as enfermidades infecciosas, os acidentes, a desnutrição etc. O conhecimento das ocorrências endógenas e exógenas é de suma importância, tendo em vista que elas são causas para o surgimento de problemas intelectuais, de conduta, de aprendizado e outros.

Deve-se explorar o desenvolvimento das diferentes habilidades: linguagem, controle dos esfínteres, motricidade, socialização do choro e das emoções etc.

A falha ou a demora na aquisição dessas habilidades (independentemente da etiologia) colocam a criança em séria desvantagem ante as exigências de seu meio e são, em última instância, um agravo à sua auto-imagem. Paralelamente, o não-desenvolvimento adequado dessas habilidades pode indicar desde deficiências maturacionais, privação de estimulação necessária ao desenvolvimento, condutas inadequadas dos que convivem com a criança, motivadas por falta de conhecimento e/ou pela própria problemática emocional (o que é freqüentemente observado no treino de toalete, quando, não raras as vezes, a criança é submetida ao treinamento precoce ou o não-controle esfinteriano é tolerado e até reforçado além da idade esperada), até comprometimentos neurológicos.

Ainda aqui, a pesquisa das reações afetivo-emocionais da criança, ao longo de sua evolução, tais como perturbações do sono, manifestações ansiosas, fobias, isolamento, agressividade etc., pode não só explicar o contexto familiar no qual estava inserida, mas também nos indicar o pano de fundo sobre o qual se desenvolveu o quadro atual.

c. Escolaridade

A exploração das áreas acadêmicas deve ser complementada com a descrição das características pessoais e evolutivas concernentes a essas etapas do desenvolvimento, pois, muitas vezes, o que se chama de problema de aprendizagem é, de fato, apenas a resultante de dificuldades emocionais (como, por exemplo: impulsividade, dificuldade de relacionamento, ansiedade de desempenho). Os

dados a serem obtidos aqui se referem à idade em que foi à escola e como se deu a adaptação a ela (sua relação com as normas da instituição e interações sociais); às áreas acadêmicas em que encontrou dificuldade e as que preferia; à evolução (foi reprovado ou não) e a suas consequências (objetivas e subjetivas).

É necessário ter conhecimento dos últimos anos de escolaridade, especialmente no que se refere a suas aspirações e possibilidades materiais para continuar sua formação, de tal modo que a ocupação futura, se possível, guarde correspondência com sua atitude e vocação. A não-concretização desses ideais, com frequência, é motivo de frustrações e desordens psicológicas.

Deve-se completar com uma descrição dos aspectos emocionais, motivacionais e afetivos do escolar, uma vez que o rendimento acadêmico é facilitado ou dificultado por esses fatores.

d. Adolescência e juventude

A puberdade, a adolescência e a juventude são etapas de crises, de diferenciação e problemas. Devem ser exploradas em razão da natureza do desenvolvimento e das atividades desempenhadas nesses anos, já que as variáveis (condicionantes) ambientais e sociais determinam qualitativamente essas etapas e modificam quantitativamente cada estágio do desenvolvimento.

É necessário pesquisar os comportamentos, valores e atitudes durante a puberdade e a adolescência em relação às suas emoções, o ajustamento social, as relações homo e heterossexuais e os níveis autovalorativos e críticos.

A diferenciação dos caracteres sexuais secundários, bem como as mudanças em razão do crescimento físico, alteram o Esquema Corporal (e, assim, a imagem de si mesmo), o que contribui para o aparecimento de conflitos e dificuldades em relação à auto-estima, à sexualidade e, de forma mais ampla, ao relacionamento interpessoal.

A juventude, etapa de estabilização de comportamento e concretização de ideais, deve ser

explorada minuciosamente, porque boa parte dos comportamentos futuros começa a consolidar-se nesses anos.

e. Vida sexual

Começa-se a pesquisar a vida sexual, a partir do desenvolvimento. Deve-se perguntar a idade em que identificou seus órgãos sexuais e em que aprendeu a diferenciar o homem da mulher, bem como quando começou a perceber a sua excitabilidade sexual. Mais adiante, deve-se perguntar quando começou a ter interesse pelo sexo oposto e a forma como este foi canalizado. Deve-se questionar sobre as primeiras experiências amorosas, referentes tanto a contatos físicos, como as sentimentais (emocional), e a forma como ambos os níveis foram desenvolvidos (canalizados).

A pesquisa sobre o tipo de informação e formação (valores transmitidos pelos diversos grupos sociais a que o paciente pertenceu) recebidas sobre a sexualidade é condição indispensável para a compreensão das atitudes e sentimentos do paciente, nesse contexto.

Devem-se explorar, assim, a primeira relação sexual, os papéis sexuais e sociais, a afetividade envolvendo expectativas e padrões. Dessas entrevistas, podem-se obter dados sobre problemas conjugais e inadequações, os quais, por sua vez, permitirão compreensão adequada e estabelecimento de estratégias.

f. Hábitos e interesses

É necessário conhecer a forma como o paciente se integra, assimila e participa dos costumes de sua sociedade. A descrição de seus hábitos e interesses nos permite esse objetivo, o que possibilitará conhecer o grau de ajustamento social, assim como suas possibilidades de desenvolvimento, autonomia ou dependência; características essas que poderão ser utilizadas pelo psicólogo com fins corretivos ou terapêuticos. Além do mais, deve-se indagar sobre o interesse que tem diante dos acontecimentos sociais, políticos, religiosos etc.

g. Atitudes

É importante explorar esta área para conhecer a forma como percebe os acontecimentos e a realidade exterior, no que e o quanto o paciente mostra sua disponibilidade afetiva e cognitiva ante a determinada circunstância. Deve-se perguntar pelas atitudes perante a sua enfermidade, a família, o trabalho e outros acontecimentos. É necessário ressaltar esses dados porque, além da utilidade no diagnóstico, as atitudes incidem significativamente na persistência ou na redução de sua problemática.

D – HISTÓRIA FAMILIAR

É importante elaborar a história familiar, porque nos possibilitará entender melhor os problemas que afligem o paciente, o modo como ele e a família poderão atuar, a fim de que seja possível uma solução para o caso. A família repercute sobre o paciente em dois níveis: biológico hereditário (menos freqüente nos problemas psicológicos); e como modelo de aprendizagem (mais freqüente).

Devem-se considerar dados dos pais, irmãos e outros familiares, consangüíneos ou não. A idade dos pais e irmãos, referências de sua saúde física/mental e outros informes devem completar-se com dados sobre os tipos de comportamento, caráter, costumes, motivações etc. e sobre as formas de inter-relação com o paciente no transcurso de seu desenvolvimento.

E – HISTÓRIA SOCIOECONÔMICA E OCUPACIONAL

Deve-se caracterizar o paciente do ponto de vista socioeconômico e, nesse sentido, questionar o lugar e o tipo de habitação, tipo de trabalho, remuneração recebida, assim como o seu grau de instrução, com o objetivo de avaliar multidimensionalmente os problemas apresentados.

Conhecer o nível socioeconômico dará idéia da qualidade de vida do paciente, fator esse intimamente associado ao ajuste emocional.

Dado que o trabalho é condição necessária para a realização de todo ser humano, deve-se questionar sobre o tipo de trabalho que desempenha e se está satisfeito com ele ou não. O interesse e a motivação pelo trabalho que a pessoa realiza permitem uma adaptação satisfatória e, provavelmente, evitarão pessoas desmotivadas, que desempenham trabalhos que não lhes agradam; isso naturalmente ante a carência de oportunidades e pela necessidade de sobrevivência. Do mesmo modo, é importante saber se a pessoa tem ou não capacidade para desempenhar satisfatoriamente o trabalho que está realizando.

No ambiente de trabalho, existem modos de interação grupal entre trabalhadores e destes com os níveis hierárquicos; não são poucos os problemas psicológicos gerados a partir das interações inadequadas, pelo que se recomenda descrever esses detalhes.

Considerando-se que o trabalho não é só meio de subsistência, senão um meio de realizações pessoais, será importante consignar dados das qualificações, promoções ou incentivos para esses ganhos; ainda que, lamentavelmente, em muitos lugares as condições de trabalho, se existem, são degradantes e frustrantes.

Se o estudo realizar-se com escolares, pode ser importante descrever as aspirações, atitudes e possibilidades acadêmicas.

II – EXAME CLÍNICO PSICOLÓGICO

Mediante a anamnese, deveremos ter obtido os dados históricos que contribuirão com a sistematização dos problemas.

Como um procedimento paralelo e complementar à anamnese, é importante constatar objetivamente esses problemas, isto é, o profissional, através de seus órgãos sensoriais, facilitados por sua experiência e capacidade de análise crítica, deve corroborar, durante as entrevistas e observações, a

presença de tais sinais para associá-los, em sua real magnitude, a cada problema e, inclusive, detectar alguns que não fazem parte das preocupações do paciente.

A esse procedimento chamamos de exame clínico psicológico, o qual se subdivide nas seguintes áreas:

- A – Observação das características gerais do comportamento
- B – Exploração dos processos cognitivos
- C – Exploração dos estados emocionais
- D – Exploração das atitudes sociais

A – OBSERVAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS GERAIS DO COMPORTAMENTO

- a. Descrição física
- b. Consciência e níveis de alerta
- c. Estados emocionais
- d. Motricidade
- e. Condutas sociais

O estudo dessas características é eminentemente observacional e ectoscópico, e torna-se necessário porque permite observar o paciente de forma panorâmica, envolvendo uma exploração breve das distintas áreas psicológicas.

a. Descrição física

O estudo começa pela descrição física do paciente: a vestimenta, o cuidado pessoal, higiene, características antropomórficas e estado de nutrição. Esses dados nos darão uma idéia do cuidado geral do paciente, bem como poderão alertar-nos, por exemplo, para sua identificação sexual, faixa etária etc. e, ainda, para os estados de humor e sua auto-imagem.

b. Consciência e níveis de alerta

Em segundo lugar, devem-se determinar os estados de consciência, posto que sua presença é condição essencial para que ocorra qualquer processo mental, do mesmo modo que cada nível de consciência incide significativamente nas tarefas

intelectuais. A excitabilidade provocada pela ingestão de drogas, por exemplo, impede a atenção seletiva, ao passo que os estados de confusão mental (traumática ou psicótica) podem facilitar o surgimento de idéias delirantes. A fluência verbal com conteúdo significativa (princípio, meio e fim) é um forte indicador para a identificação desses processos.

c. Estados emocionais

Os estados emocionais do paciente podem ser observados pela expressão facial e pela postura corporal, tom de voz e ritmo de fala. A essas observações, junta-se o relato do paciente.

É relevante verificar se há correspondência entre o que se observa e o relato do paciente (discrepâncias ou paradoxos estão presentes em problemáticas severas).

d. Motricidade

A observação da motricidade – ou, mais especificamente, da psicomotricidade (andar, gesticular, destreza, mímica etc.) – torna-se, muitas vezes, elemento decisivo em um diagnóstico diferencial (por exemplo: a classificação catatônica para a esquizofrenia é essencialmente um sintoma motor).

Em alguns casos, essa observação determinará a necessidade de exames complementares específicos.

e. Condutas sociais

As motivações, as atitudes, o nível de colaboração diante do exame e o grau de aceitação de seus problemas nos darão uma idéia das condutas sociais do paciente.

B – EXPLORAÇÃO DOS PROCESSOS COGNITIVOS

- a. Atenção e concentração
- b. Processos perceptuais
- c. Orientação espacial e temporal
- d. Memória
- e. Pensamento e linguagem
- f. Inteligência

a. Atenção e concentração

O estudo dos processos mentais inicia-se com a exploração da atenção. Deve-se ter em conta a intensidade, o volume e o limiar da mesma.

A concentração será avaliada com base na persistência da atenção seletiva. A conservação da seqüência de uma conversação e provas como o traçado de letras e números, ou pedindo ao paciente que diminua, desde 100, de 7 em 7, ou desde 30, de 3 em 3, dentre outras, são formas de explorar a atenção.

A distração como dificuldade da atenção é observada freqüentemente na maioria de distúrbios emocionais, mentais e intelectuais de qualquer etiologia. Igualmente, sua perturbação usualmente afeta a memória e o pensamento.

b. Processos perceptuais

O estudo da percepção se faz com base no reconhecimento dos diferentes objetos que existem na realidade. Devem-se avaliar a percepção visual (reconhecimento de objetos, cores, símbolos etc.), a percepção auditiva (melodias, sons, ruídos, palavras etc.) e a percepção tátil a partir da discriminação das características externas dos objetos.

Há um conjunto de perturbações da percepção; as alucinações, as ilusões e as agnosias são sinais clínicos dessas perturbações. O primeiro caso geralmente corresponde a um problema psicótico, mas também pode-se ver nas intoxicações e nas perturbações cerebrais; o segundo está relacionado à fadiga, causando o estresse; ao passo que a agnosia caracteriza um comprometimento neurológico.

c. Orientação espacial e temporal

É possível explorar a orientação espacial a partir da discriminação do esquema corporal (direita-esquerda), orientação topográfica (lugares), em coordenadas espaciais (acima, abaixo, adiante, atrás), orientação simbólica (que leia ou escreva: p, d, q, b, 6, 9) etc. As dificuldades

encontradas aqui podem, muitas vezes, justificar os problemas de aprendizagem e de desempenho, de forma geral.

Explora-se a orientação temporal com o reconhecimento do dia, hora, mês, ano e estações correspondentes. Os pacientes com problemas emocionais agudos usualmente não recordam o dia, nem a data em que se encontram, ao passo que os psicóticos podem estar convencidos de que estão no dia, mês e ano totalmente diferentes.

Os mecanismos de orientação temporal a que nos temos referido correspondem a uma codificação conceitual; do mesmo modo, deve-se ter em conta aqueles de codificação mordaz (pictória), quer dizer, por experiência imediata do tempo que transcorre. Por exemplo, o cálculo da hora do dia que poderia ser neste momento ou a quantidade de tempo que transcorre de um momento a outro.

d. Memória

A exploração clínica da memória é relevante, sobretudo em adultos, dada a alta freqüência dos problemas nessa área. Podem existir *déficits* primários ou secundários no processamento cognitivo da memória (registro, retenção, consolidação e recordação). No comprometimento primário de quaisquer desses níveis, podem existir comprometimentos cerebrais específicos, ou seja, falhas nos segmentos responsáveis de cada modalidade. Por exemplo: lesões no lóbulo occipital geram *déficits* de registro e retenção visual, ao passo que falhas nos sistemas hipocâmpicos geram defeitos de consolidação.

As perturbações secundárias ou funcionais de memória são as mais freqüentes no ser humano: nas crianças se traduzem como problemas de aprendizagem e nos adultos mediante os famosos “esquecimentos”. Em ambos os casos, há interferências emocionais. Na depressão e na ansiedade, dado que o paciente não dispõe do estado emocional adequado, há dificuldade para guardar (reter) as experiências vividas.

Nos idosos, os *déficits* de retenção são mais freqüentes que os de evocação, ou seja, para eles é mais difícil recordar as atividades dos últimos dias e mais fácil evocar suas experiências do passado. Na demência senil, observam-se *déficits* em ambos os níveis. Igualmente, as pessoas deprimidas e ansiosas têm dificuldades para guardar (reter) tarefas a curto prazo.

e. Pensamento e linguagem

Devem-se explorar o curso, o conteúdo e a forma do pensamento. *Déficits* no curso podem ser devidos a perturbações emocionais, ainda que o problema no conteúdo, por carecer de coerência e juízo lógico, geralmente seja de caráter psicótico. Se um paciente está falando de seu negócio na sapataria associa a conversação que teve com sua esposa sobre seus filhos, e quando começa a contar-nos novamente, desvia o assunto com temas de hípica, sem ter completado nenhuma das idéias, este caso corresponde a uma “fuga de idéias”, que freqüentemente se observa em sujeitos maníacos. Existem outros pacientes que preferem escutar seus próprios pensamentos, que acreditam que suas idéias têm sido subtraídas, que se consideram um ser sobrenatural etc. Essas formas de pensamento usualmente caracterizam algumas psicoses. Igualmente, devem-se estudar os níveis de conceituação no paciente, já que estes estão em relação à capacidade intelectual; por essa razão, o deficiente mental, a criança e o deteriorado têm níveis concretos, ao passo que o adulto possui um nível abstrato.

Os problemas de pensamento devido a perturbações cerebrais específicas são menos freqüentes, já que é uma função altamente diferenciada; em contrapartida, as perturbações difusas, como a demência arteriosclerótica, causadas por deterioramento intelectual, geram um pensamento de nível concreto.

A linguagem deve ser estudada de dois aspectos: a compreensão e a expressão. Um problema de compreensão pode indicar defeito do tipo afásico, ou, também, ser esquizofrênico; o

afásico, apesar do seu problema de comunicação, apresenta condutas coerentes, ao passo que o esquizofrênico distorce deluzivamente a informação e suas condutas são ilógicas.

As perturbações na expressão verbal correspondem a defeitos articulatórios ou a defeitos para a generalização lingüística. O gago apresenta *déficit* articulatório, o qual geralmente é de causa emocional, ao passo que a “disartria” é também um defeito articulatório, mas de base orgânica. Quando o defeito articulatório se agrava em determinadas circunstâncias – sobretudo pela tensão emocional – e melhora a fluidez verbal quando há tranqüilidade, estamos diante de uma “gagueira” ou “espasmofenia”; em contrapartida, quando o defeito articulatório é persistente e o sujeito está emocionalmente tranqüilo, mas usa comunicar-se com gestos, mímica ou escrita, então provavelmente será um disártrico.

Em alguns casos, é necessário haver um estudo minucioso de linguagem que explore áreas perceptuais, semânticas, gramaticais etc. (vide exames auxiliares).

f. Inteligência

A exploração tradicional da inteligência limitava-se à administração de determinados testes psicológicos; sem dúvida, em clínica, é necessário, além disso, partir das análises de eficiências em habilidades distintas observadas durante o exame, o que nos permite ter uma idéia cabal do nível qualitativo. O estudo da eficiência da atenção, das habilidades perceptuais, da retenção, das destrezas motoras, da formação de conceitos, do juízo e da razão, por exemplo, nos permitirá conhecer cada habilidade em particular.

Como complemento ao anterior, podemos recorrer aos dados históricos (qualificações, referência de professores, promoções etc.) para termos uma idéia do seu desenvolvimento e do estado atual das habilidades intelectuais, porque é possível de que a inteligência atual seja menor, por deteriorização, que a de alguns anos. Naturalmente, o nível quantitativo da evolução é necessário por

sua importância metodológica; ele é obtido por intermédio das provas psicométricas devidamente padronizadas. Não se deve entender a inteligência como um processo mental – mas, sim, deve-se inscrevê-la em cada um deles – pelo qual é possível chegar a ela a partir do conhecimento da eficiência de cada tarefa mental.

C – EXPLORAÇÃO DOS ESTADOS EMOCIONAIS

A exploração dos estados emocionais deve começar caracterizando os aspectos básicos das emoções; o tom emocional e os estados de ânimo que correspondem a esse nível, e não dependem diretamente de nenhuma representação ou idéia, têm certa autonomia e são uma forma peculiar de ser e viver, mas ao mesmo tempo frágil e sensível.

A irritabilidade, a impulsividade e a apatia são transtornos do humor que se observam com frequência nos problemas emocionais de personalidades e intelectuais, assim como nos problemas metabólicos e endógenos.

A afetividade, o sentimento e as paixões são formas diferenciadas de emoções; estão em relação com as necessidades surgidas no curso do desenvolvimento histórico do indivíduo. No caso dos problemas depressivos, elas têm características de indiferença, pessimismo e melancolia.

A alegria, por exemplo, é uma valorização cognitiva afetiva por algo que logicamente resulta agradável; e nos psicóticos é usual observar a distorção dos afetos. Neste nível, é valioso perguntar o que sente por seus pais, por seu cônjuge ou outros, e se isso corresponde à forma como se relaciona com eles. A referência, que a respeito nos brindam a família e companheiros de trabalho, será valiosa.

Os sentimentos morais, estéticos ou religiosos são níveis superiores das emoções e úteis de explorar em todos os pacientes, sobretudo naqueles em que se suspeitam problemas psicóticos. A vontade como capacidade de energia, a persistência e o vigor para o atingir das metas podem ser deficientes em deprimidos ou exagerados em síndromes maníacas.

D – EXPLORAÇÃO DAS ATITUDES SOCIAIS

Existe um grupo de manifestações psíquicas que se expressa nos modos de interação social do sujeito em seu ambiente familiar, de trabalho e de amizades; elas devem ser ações antecipadas, planejadas e adaptáveis às situações variáveis que o meio oferece. Assim mesmo, ante tais circunstâncias, o sujeito deve mostrar condutas coerentes, ações lógicas e reações emocionais mais ou menos de acordo e que correspondam à cultura, às regras sociais, aos valores morais, religiosos e éticos de seu grupo social respectivo.

Quando vamos a uma festa, geralmente estamos predispostos a nos distrair ou, no caso de uma cerimônia religiosa, assumimos atitudes reverentes; e quando na rua nos encontramos com uma pessoa alheia que nos fala amigavelmente, nos mostramos reservados.

Apresentam-se alterações nas diferentes modalidades das atitudes sociais, principalmente, indivíduos em transtornos psicopáticos de personalidade, psicóticos e com síndromes pré-frontais. Alguém que atua insolentemente somente por sentir prazer ao provocar danos aos outros provavelmente deve tratar-se de um psicopata. Outra pessoa que, em uma cerimônia pública, ainda que os demais se achem concentrados no referido ato, expressa euforia e se dirige afetuosamente a uma pessoa desconhecida, acreditando estar falando com um amigo, poderá tratar-se de um esquizofrênico. Um paciente com síndrome pré-frontal (comprometimento cerebral), sem ser psicopata ou psicótico, pode chamar pelo nome o médico, enquanto este o examina, e fazer suas necessidades primárias na presença do pessoal de enfermaria, apesar de poder, por seus próprios meios, dirigir-se aos serviços higiênicos. Com frequência, os transtornos mentais desses pacientes surgem provocando perturbações no plano das atitudes sociais sem que antes se evidenciem desordens das demais esferas cognitivas ou afetivas. Por isso, é importante realizar o exame do caso desde o início da enfermidade.

A exploração dessa esfera deve realizar-se durante o exame clínico mediante a observação das atitudes correspondentes; igualmente, é valioso obter tal informação por intermédio dos familiares, amigos ou companheiros de trabalho. Deve-se perguntar por seus diversos interesses (familiares, econômicos, recreacionais), pela dedicação que mostra em suas atividades cotidianas, pelos tipos de entretenimentos, os que mantém ou as mudanças constantes, por suas aspirações a curto, médio ou longo prazo etc., com o fim de evidenciar seus níveis de ajuste, autonomia emocional e sua independência e criatividade para a solução de diversos problemas, como formas superiores de expressão da personalidade e do intelecto do tal sujeito.

Até o momento, temos demonstrado as estratégias necessárias para a acumulação dos dados históricos da anamnese, e as pautas para a exploração clínica; as primeiras contribuem para tipificar os sintomas e visualizar as possíveis fontes causais do problema, ao passo que as segundas permitirão a constatação objetiva dos problemas a partir da observação dos sinais. Ambas, por sua vez, possibilitarão obter o “diagnóstico clínico” dos problemas que afligem o paciente.

A verificação, a validação e o aprofundamento do estudo deverão ser efetuados através dos exames complementares e auxiliares.

III - EXAMES COMPLEMENTARES E AUXILIARES

Para corroborar o diagnóstico clínico, deve-se recorrer às provas psicológicas, a fim de que, contrastando os resultados de ambos os métodos de estudo, se encontre uma coincidência nos referidos resultados, se estes forem aplicados adequadamente. Dessa maneira, serão obtidas a validade e a certeza necessária para o diagnóstico final do caso, já que o mesmo problema foi avaliado por diferentes meios.

A escolha do instrumento deve partir da necessidade de se estudarem determinadas áreas do psiquismo, as mesmas que se consideraram necessárias avaliar sociometricamente, com base na abordagem clínica. Não é conveniente administrar indiscriminadamente uma bateria de testes sem antes haver abordado semiologicamente o problema, a menos que se esteja efetuando um estudo experimental; já que existe ampla gama de testes para diferentes esferas psicológicas, não se deve lançar mão desses instrumentos enquanto não se saiba qual deles usar, nem que esferas avaliar.

No apogeu das correntes psicométricas, consideravam-se como estudo psicológico de maior solidez aqueles estudos cujos resultados eram minuciosamente quantificados, mas obtidos de testes psicológicos sem maior consideração dos aspectos comportamentais, observacionais e históricos do sujeito; consideração essa até certo ponto compreensível e aceitável, porque se apresentava como uma alternativa ante a especulação da psicologia subjetiva que havia precedido. Mesmo atualmente, alguns psicólogos e outros profissionais de áreas relacionadas preferem essa forma de trabalho, porque já estão adaptados a ela ou porque é a melhor maneira de ver o psicólogo como um elemento auxiliar nas tarefas de evolução e diagnóstico. Um instrumento que, além de corroborar o diagnóstico, permite aprofundar o estudo do caso, porque existem perturbações “mascaradas” por outros sintomas, e que somente as observações clínicas podem não ser suficientes em avaliar.

Por outro lado, as provas psicométricas informam quantitativamente acerca das funções que medem e, para isso, é necessário padronizá-las previamente. Ambos os processos são valiosos, porque permitem metodologicamente comparar e hierarquizar as condutas do paciente dentro da instrumentação. Quando uma prova de inteligência nos informa que determinada pessoa tem um Q.I. de 100, pensamos que sua inteligência se encontra

dentro do esperado para a classe a que pertence e, portanto, é normal. Tampouco é conveniente que o profissional se conforme com resultados quantitativos, já que os dados procedentes da observação enriquecerão qualitativamente o estudo integral do caso.

Reiteramos que o diagnóstico definitivo do caso surgirá progressivamente; mediante os sintomas e sinais, surge o diagnóstico sindrômico; vários destes determinam o diagnóstico clínico e mediante os exames auxiliares se comprova ou se justifica a profundidade dos métodos anteriores. O diagnóstico em psicologia tem merecido inovações importantes. Anteriormente, interessava conhecer o diagnóstico etiológico, de modo que havia um rótulo para o paciente; com frequência, isso dificultava o trabalho terapêutico. O ressurgimento dos enfoques nos comportamentos permite o estabelecimento dos diagnósticos funcionais, ou seja, a valorização diagnóstica em razão das possibilidades terapêuticas e educativas.

Se bem que a inovação seja um procedimento acertado e finalista, para melhor proveito de seu alcance, torna-se importante veiculá-lo complementarmente com as valorizações etiológicas ou causais, já que vários casos, apesar de terem perturbações de condutas similares, vão diferenciar-se substancialmente a partir de suas causas ou condicionantes.

Finalmente, é útil particularizar o estado de cada uma das habilidades, além dos resultados neurológicos, já que é de pouca utilidade prática dizer que um caso tem um retardamento mental moderado, se além disso não informamos o estado de cada uma das habilidades que integram a função mental (habilidades lingüísticas, perceptuais, atencionais, perceptivo-motoras etc.). De maneira que, em um estudo que particulariza áreas, abstrai a generalidade e conhece ainda os fatores etiológicos do problema, encontramos não só a maior possibilidade de o diagnóstico ser válido, como também a perspectiva de uma terapia psicológica eficiente.

IV - PLANO DE TRATAMENTO

É necessário adequar o estudo de um caso clínico, precisamente quando procede de uma interconsulta, ao “Parecer Psicológico”, documento formal e legal que o psicólogo emite para uso e conhecimento de outros profissionais ou instituições e que o diferencia da história clínica; não é um documento de trabalho, nem de uso reservado.

É desejável, e em favor dele se observa com agrado nos últimos anos, que o estudo dos casos tenha cada vez menos fins estritamente diagnóstico-avaliativos, e cada vez mais se desenvolvam alternativas terapêuticas, dado que na maioria dos casos de transtornos psicopatológicos, quando recebem tratamento somente farmacológico, obtêm-se melhoras transitórias, e não remissões ou curas duradouras.

Nenhuma opção psicoterapêutica – e, menos, ainda o tipo de técnicas a usar – deve surgir espontaneamente, mas só após estudo sistemático e progressivo do caso. O emprego de técnicas depende não só da orientação teórica do psicólogo, prática freqüente em nosso meio, mas também das necessidades surgidas como produto da investigação científica (anamnese) a que foi submetido o paciente.

O plano de tratamento vem a ser a planificação e a programação de um conjunto de estratégias para abordar com êxito a solução do problema. Para isso, deve-se ter em consideração o tipo de perturbação (sintomas, sinais e síndromes) e seus antecedentes, com o afã de delinear os objetivos terapêuticos, valorizar a personalidade e a inteligência do paciente, já que são os recursos que favorecem ou interferem na solução do problema.

Igualmente, deve-se ter em conta as características socioeconômicas, culturais e ocupacionais do sujeito, já que o êxito do programa se assegurará adequando-o à realidade circundante em que o caso se acha imerso.

O programa terapêutico não se deve reduzir a determinadas sessões. Este deve incluir as atividades globais e particulares do paciente. Deve-se fazer participar, igualmente, as comunidades familiar e ocupacional.

V - EVOLUÇÃO

O curso de uma enfermidade, quando recebe o tratamento apropriado, nem sempre se encaminha para a “cura” definitiva e, entre os fatores que a facilitam ou nela interferem, seguem sendo os culturais, econômicos, pessoais e a própria natureza da enfermidade.

Logo que for efetuado o diagnóstico e implementado o programa de tratamento, devem-se fazer avaliações periódicas do caso, considerando, dentre outros, a análise do efeito do programa terapêutico (*feedback*), o curso natural da enfermidade, as condições pessoais (interesses, atitudes, personalidades etc.) e materiais (recursos econômicos) do paciente.

A análise resultados, produtos da implementação do plano terapêutico, deve ser feita periodicamente. Pode ser necessário que no caminho se incluam reajustes ou se modifiquem determinadas táticas e estratégias, com o fim de alcançar o objetivo proposto e, inclusive, caso não sejam obtidos os resultados esperados, devem-se buscar novos programas. É conveniente controlar os fatores pessoais e materiais até onde seja possível, com o fim de que eles, ao se manterem nos níveis ótimos, resultem favoravelmente na reabilitação do sujeito.

Depois de um tempo prudente e a partir dele, periodicamente, deve-se avaliar clínica e psicometricamente o paciente, para se comparar com os estados clínicos anteriores e, também, obter novos critérios que poderão determinar uma nova forma de atenção a ele.

A terapia ou reabilitação psicológica diferencia-se da médica, usualmente pelo tempo prolongado, uma vez que a maioria dos condicionantes da problemática também esteve presente por muito

tempo. Em tal sentido, a idéia é não fazer custosa e, portanto, luxuosa a terapia em saúde mental. O tipo de atendimento proposto deve abranger a população em sua maioria e, portanto, há a necessidade de que o profissional, sem ser exclusivista, encontre novos métodos, faça participar a família, local de trabalho e outras instituições ou agentes terapêuticos, não só para a economia do paciente, mas para que a terapia seja integral e efetiva.

VI - IMPORTÂNCIA DAS HABILIDADES EMPÁTICAS

Hoje, a avaliação deixou de ser concebida como uma etapa anterior ao processo terapêutico e imune às variáveis que o influenciam. Tanto quanto a terapia, a avaliação acontece no contexto da relação terapeuta-cliente e, por isso, é suscetível aos condicionantes dessa relação.

Sabe-se que as habilidades empáticas do terapeuta são fundamentais para o desenvolvimento satisfatório de todo o processo terapêutico: desde a avaliação diagnóstica até a implementação das estratégias de tratamento.

Durante a fase de coleta de dados e avaliação, a atitude empática do terapeuta é responsável pela promoção de sentimentos de confiança no paciente, aumentando, assim, sua cooperação em fornecer as informações necessárias. Além do mais, a empatia do terapeuta favorece, desde o início, a mobilização de expectativas positivas no paciente em relação à solução do seu problema, aumentando, então, sua motivação para o tratamento e reduzindo seus eventuais sentimentos de culpa e/ou incompetência.

Por tudo isso, assegurar o caráter empático da relação terapeuta-cliente, desde o seu início, é muito importante.

Numerosos estudos têm apontado que a empatia do terapeuta é influenciada pelo seu grau de diretividade, suas expressões faciais, tom de voz, dentre outros. Acreditamos que esses aspectos, aliados à capacidade de autopercepção e

autoconhecimento do terapeuta, não apenas determinam o quanto ele é percebido como empático pelo paciente, como também facilitam e o recompensam no desempenho do seu papel.

Para desenvolver habilidades empáticas, antes de tudo, é necessário que o terapeuta faça uma análise cuidadosa de si, discrimine seus modos de ação e seus sentimentos em situações interpessoais. Assim, conhecendo-se e desenvolvendo sua capacidade de observação, ele terá condições de entrar em sintonia com o mundo do cliente, o qual, na maioria das vezes, é bastante diferente do seu (o cliente pode pertencer a uma classe socioeconômica-cultural mais elevada ou menos elevada que a do terapeuta, ou ainda pertencer a “classe dos miseráveis”).

Entrar em sintonia com o cliente requer, do terapeuta, sensibilidade tanto para aquilo que o cliente, explicitamente, diz, como para aquilo que ele expressa através de seus comportamentos não-verbais (posturas, movimentos, expressões faciais, omissões etc.).

Essa tarefa parece particularmente difícil para o terapeuta em formação. Nossa experiência docente mostra-nos que o jovem terapeuta, preocupado em coletar dados do cliente, acaba por negligenciar as variáveis envolvidas na sua relação com ele. Não raras as vezes, preocupado com a sua identificação profissional e com a valorização do seu papel social, atua de forma mecanicista, com excessos de formalismo e impessoalidade.

Inversamente, é comum também, devido à ansiedade em relação ao novo papel e à necessidade de parecer competente aos olhos do cliente e por ele ser aceito, atitudes que conduzem o terapeuta inexperiente a uma postura paternalista e cuidadora em relação ao cliente.

Com certeza, tanto o estilo “frio” e padronizado, quanto atitudes condescendentes, indiferentes, críticas, desaprovadoras ou incrédulas não serão percebidas, pelo cliente, como empático e conseqüências negativas disso sobre os resultados terapêuticos serão inevitáveis.

VII - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BARACH, Z. – **Introdução à Prática Psicoterapêutica**, E.P.U./EDUSP, São Paulo, 1982.
- _____. **Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento da CID-10**, OMS, Editora Artes Médicas, Porto Alegre, 1993.
- GESSEL, A.; AMATRUDA, C. – **Diagnóstico del normal y anormal del niño**, Editora Paidós, Buenos Aires, Argentina, 1977.
- GESSEL, Arnold – **Diagnóstico del desarrollo**, Editora Paidós, Buenos Aires, Argentina, 1976.
- KAPLAN, H.I.; BENJAMIN, J.; GREBB, J.A. – **Compêndio de Psiquiatria: ciências do comportamento e psiquiatria clínica**, 7ª ed., Editora Artes Médicas, Porto Alegre, 1997.
- LEFREVE, A.B.O. – **Exame neurológico evolutivo**, Editora Sarvier, São Paulo, 1972.
- _____. **Manual de Diagnóstico e Estatística de Distúrbios Mentais DSMIII-R**, Editora Manole, São Paulo, 1989.
- SANTOS, C.C. – **Dislexia específica de evolução**, Editora Sarvier, São Paulo, 1975.

EXAME CLÍNICO E PSICOLÓGICO (ANAMNESE)

Hipólito Carretoni Filho
Helena Bazanelli Prebianchi

ROTEIRO I

DATA: _____ LOCAL: _____

I) IDENTIFICAÇÃO

Nome: _____ Idade: _____ Sexo: _____

Profissão: _____ Estado civil: _____ Etnia: _____

Pai: _____ Idade: _____ Profissão: _____

Mãe: _____ Idade: _____ Profissão: _____

Esposo(a): _____ Idade: _____ Profissão: _____

Irmãos (1) _____ Idade: _____ Profissão: _____ Sexo: _____

(2) _____ Idade: _____ Profissão: _____ Sexo: _____

(3) _____ Idade: _____ Profissão: _____ Sexo: _____

(4) _____ Idade: _____ Profissão: _____ Sexo: _____

(5) _____ Idade: _____ Profissão: _____ Sexo: _____

II) MOTIVO DA CONSULTA

III) ENFERMIDADE ATUAL

a) Tempo _____

b) Forma de início _____

c) Sintomas principais (descrição) _____

d) Sintomas secundários (descrição) _____

e) Antecedentes clínicos _____

f) Recursos utilizados anteriormente _____

IV) HISTÓRIA PESSOAL

a) Gestação _____

b) Infância _____

c) Escolaridade _____

d) Adolescência e juventude _____

e) Sexualidade _____

f) Hábitos e interesses sociais _____

g) Atitudes _____

h) História familiar _____

i) História socioeconômica e ocupacional _____

j) CID _____

h) Observações _____

ROTEIRO II

I) CARACTERÍSTICAS GERAIS OBSERVADAS DURANTE A CONSULTA

a) Descrição física	(-)			(+)
1 – Vestimenta:	a	b	c	d
2 – Cuidado pessoal (higiene):	a	b	c	d
3 – Estado de nutrição:	a	b	c	d
4 – Características antropomórficas:	_____			

5 – Outros: _____

b) Consciência e níveis de alerta	(-)			(+)
1 – Estado de consciência:	a	b	c	d
2 – Atenção seletiva:	a	b	c	d
3 – Confusão mental:	a	b	c	d

	(-)			(+)
4 – Idéias delirantes:	a	b	c	d
5 – Fluência verbal (princípio, meio e fim)	a	b	c	d
6 – Outros: _____	a	b	c	d
_____	a	b	c	d

c) Estados emocionais

1 – Expressão facial: _____

2 – Postura corporal: _____

3 – Tom de voz: _____

4 – Ritmo de fala: _____

5 – Outros: _____

d) Motricidade	(-)			(+)
1 – Andar:	a	b	c	d
2 – Destreza:	a	b	c	d
3 – Mímica:	a	b	c	d
4 – Gesticulações:	a	b	c	d
5 – Tremores:	a	b	c	d
6 – Outros: _____	a	b	c	d
_____	a	b	c	d
_____	a	b	c	d

e) Condutas sociais [durante a sessão]	(-)			(+)
1 – Motivação:	a	b	c	d
2 – Atitudes:	a	b	c	d
3 – Colaboração:	a	b	c	d
4 – Outros: _____	a	b	c	d
_____	a	b	c	d
_____	a	b	c	d

III) CONTEÚDOS ESPECÍFICOS

1) EXPLORAÇÃO DOS PROCESSOS COGNITIVOS

a) Atenção e concentração	(-)			(+)
1 – Atenção (intensidade):	a	b	c	d
2 – Atenção (limiar):	a	b	c	d
3 – Atenção (seletiva):	a	b	c	d
4 – Concentração:	a	b	c	d
5 – Outros: _____	a	b	c	d
_____	a	b	c	d
_____	a	b	c	d
b) Processos perceptuais	(-)			(+)
1 – Visual (objetivos, cores, símbolos):	a	b	c	d
2 – Auditivo (sons, ruídos):	a	b	c	d
3 – Tátil (concentração exterior a objetos):	a	b	c	d
4 – Alucinações (especificar o tipo):	a	b	c	d
5 – Outros: _____	a	b	c	d
_____	a	b	c	d
_____	a	b	c	d
c) Orientação espacial e temporal	(-)			(+)
1 – Esquema corporal (direita, esquerda etc.):	a	b	c	d
2 – Topográfico (lugares):	a	b	c	d
3 – Coordenadas espaciais (acima, abaixo etc.):	a	b	c	d
4 – Orientação simbólica (p, d, q, b, 6, 9):	a	b	c	d
5 – Temporal (dia, mês, ano etc.):	a	b	c	d
6 – Pessoas:	a	b	c	d
7 – Outros: _____	a	b	c	d
_____	a	b	c	d
_____	a	b	c	d
d) Memória	(-)			(+)
1 – Retenção:	a	b	c	d
2 – Consolidação:	a	b	c	d
3 – Recordação:	a	b	c	d
4 – Outros: _____	a	b	c	d
_____	a	b	c	d
_____	a	b	c	d
e) Pensamento e linguagem [curso]	(-)			(+)
1 – Pensamento:	a	b	c	d
1 – Conteúdo:	a	b	c	d
2 – Forma:	a	b	c	d
2 – Linguagem:	a	b	c	d
1 – Compreensão:	a	b	c	d
2 – Expressão:	a	b	c	d
3 – Outros (idéias suicidas etc.): _____	a	b	c	d
_____	a	b	c	d
_____	a	b	c	d

2) EXPLORAÇÃO DOS ESTADOS EMOCIONAIS

	(-)			(+)
1 – Apatia:	a	b	c	d
2 – Irritabilidade:	a	b	c	d
3 – Impulsividade:	a	b	c	d
4 – Afetividade:	a	b	c	d
5 – Auto-estima:	a	b	c	d
6 – Euforia:	a	b	c	d
7 – Moralidade:	a	b	c	d
8 – Religiosidade:	a	b	c	d
9 – Depressão:	a	b	c	d
10 – Outros (labilidade, agressividade etc.): _____	a	b	c	d
_____	a	b	c	d
_____	a	b	c	d

3) EXPLORAÇÃO DAS ATITUDES SOCIAIS (familiar, trabalho, amizades etc.)

III) EXAMES COMPLEMENTARES

1 - PROVAS PSICOLÓGICAS

a) Testes de nível: s _____ n _____ Quais? _____

b) Testes de personalidade: s _____ n _____ Quais? _____

c) Provas psicomotoras: s _____ n _____ Quais? _____

2 - OUTROS (psiquiátricos, clínicos, neurológicos, H.I.V. etc.)

IV) MEDICAÇÃO

1 – ESTÁ SOB MEDICAÇÃO? s _____ n _____ Quais? _____

DOSAGEM: _____

V) PARECER PSICOLÓGICO E ESTRATÉGIAS

VI) EVOLUÇÃO

Obs.: Os roteiros aqui apresentados poderão ser adquiridos em separado. Consulte o seu fornecedor.

É proibida a reprodução total ou parcial desta publicação, para qualquer finalidade, sem autorização expressa dos editores.



ISBN 85-7396-050-7



9 788573 960501